MÓDULO 7 · INVESTIGACIÓN CLÍNICA, RWE Y GENERACIÓN DE EVIDENCIA

El rol del MSL en investigación

A lo largo de este módulo se ha descrito el papel del MSL en distintos tipos de actividad de investigación —estudios iniciados por el investigador, estudios observacionales, registros, planes de generación de evidencia—, pero conviene consolidar en una lección propia la función global del MSL dentro del ecosistema de investigación clínica, porque es una de las dimensiones del rol que con más frecuencia se malinterpreta, tanto dentro como fuera de la organización.

- Consolida la función global del MSL en el ecosistema de investigación clínica
- Una de las dimensiones del rol que más se malinterpreta
- Integra lo visto en IIS, estudios observacionales, registros y planes de evidencia

El MSL no diseña estudios, no analiza datos estadísticamente, y no toma decisiones sobre qué investigación financiar: esas son responsabilidades de los equipos de investigación clínica, biostadística y estrategia médica. Lo que el MSL sí hace, de forma insustituible, es actuar como el nodo de conexión entre la realidad científica del terreno y la maquinaria de generación de evidencia de la organización. Esta función se articula en cuatro capacidades concretas, consistentes con los marcos descritos por asociaciones profesionales como la MSL Society y publicaciones especializadas como THE MSL Journal.

LO QUE EL MSL NO HACE (Y LO QUE SÍ)

- No diseña estudios, no analiza datos ni decide qué investigación financiar
- Actúa como nodo de conexión entre la realidad del terreno y la generación de evidencia
- Esta función se articula en 4 capacidades, según marcos de la MSL Society

Primero, la escucha científica activa: el MSL está en contacto directo y recurrente con investigadores, KOLs y clínicos que generan hipótesis, identifican problemas no resueltos y proponen ideas de investigación de forma continua; recoger esa información de manera sistemática es la primera capa del valor del MSL en investigación. Segundo, la orientación de proceso: cuando un investigador tiene una idea de estudio, el MSL le ayuda a navegar el proceso correcto para formalizarla —a través de canales de IIS, de colaboraciones de registro, o de propuestas a comités científicos internos— sin influir en el contenido científico de la propuesta. Tercero, la facilitación de la relación entre el investigador y los equipos internos correspondientes (investigación clínica, HEOR, asuntos regulatorios), asegurando que la comunicación fluya de forma eficiente y con la documentación adecuada. Cuarto, y quizá el más estratégico, el MSL alimenta la planificación de evidencia con inteligencia agregada del terreno, ayudando a que los planes de generación de evidencia respondan a necesidades reales y no solo a supuestos internos.

LAS 4 CAPACIDADES DEL MSL EN INVESTIGACIÓN

1. **Escucha científica activa**
   Recoge hipótesis e ideas de KOLs e investigadores
2. **Orientación de proceso**
   Ayuda a formalizar la idea sin influir en su contenido
3. **Facilitación de la relación**
   Conecta al investigador con los equipos internos adecuados
4. **Inteligencia agregada**
   Alimenta la planificación de evidencia con información del terreno

Un modelo de responsabilidad compartida bien descrito en la literatura especializada es el que compara el rol del MSL con el del Clinical Research Associate (CRA) dentro del ecosistema de investigación: mientras el CRA garantiza la ejecución operativa y el cumplimiento normativo de los estudios en curso, el MSL aporta el contexto científico, la relación de confianza con el investigador, y la conexión estratégica entre esa investigación concreta y las prioridades médicas más amplias de la organización. Ambos roles son complementarios, no intercambiables.

MSL VS. CRA

- El CRA garantiza la ejecución operativa y el cumplimiento normativo
- El MSL aporta contexto científico y conexión estratégica con las prioridades médicas
- Roles complementarios, no intercambiables

Entender con precisión estos límites y estas capacidades es lo que permite a un MSL contribuir de forma genuina a la investigación clínica sin cruzar nunca la línea hacia la influencia comercial o el diseño científico que no le corresponde, preservando así la integridad —y la credibilidad— de toda la función.

- Entender estos límites evita cruzar hacia la influencia comercial
- Permite contribuir de forma genuina a la investigación clínica
- Preserva la integridad y credibilidad de toda la función